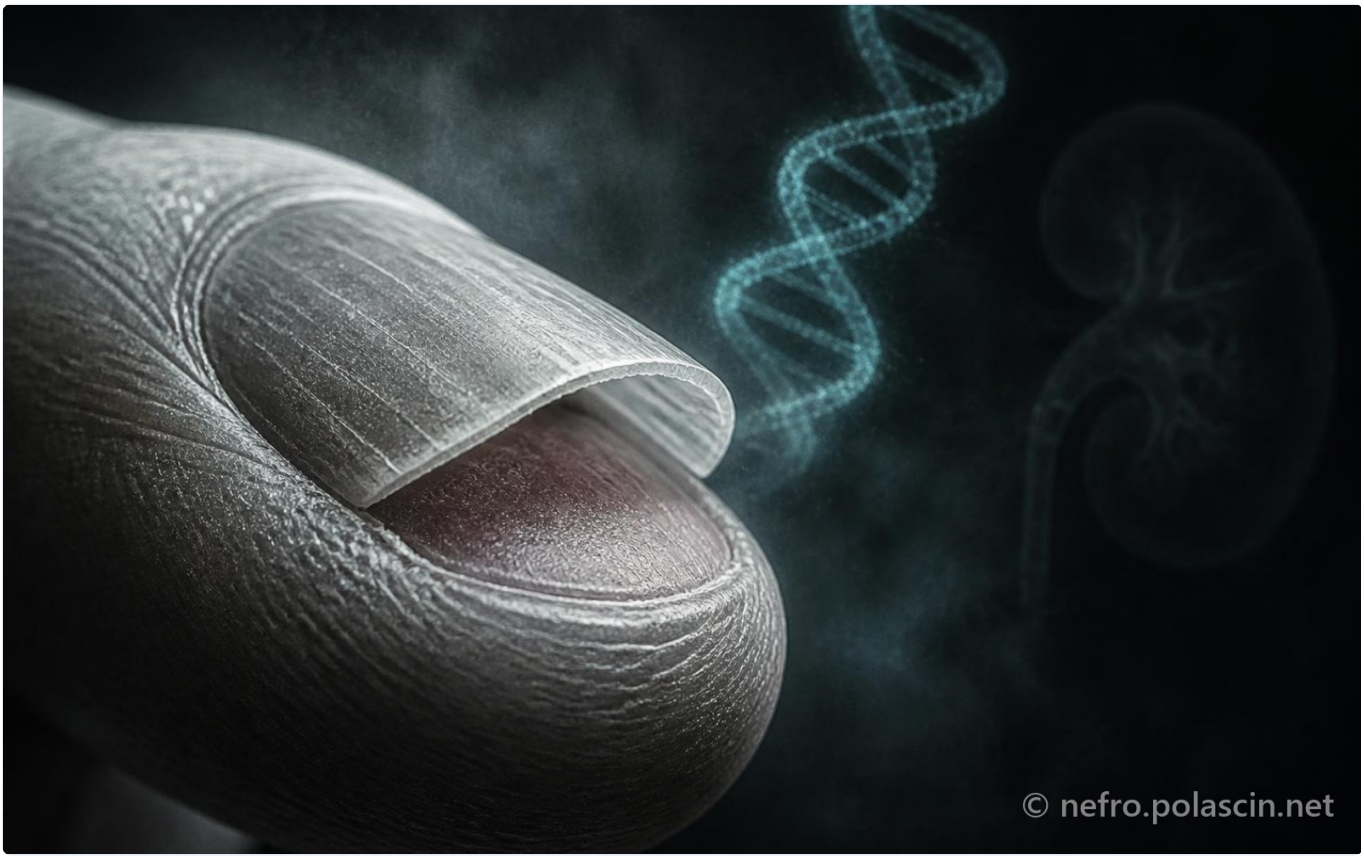
GLP-1 receptorové agonisty a onycholýza: čo skutočne ukázala štúdia z EADV 2026

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná, poloschematická scéna – nejde o snímku konkrétneho pacienta ani o zobrazenie konkrétneho výrobku. Znázorňuje odlúpenie nechtovej platničky od lôžka, teda nález, ktorý sa pri chudnutí typicky neočakáva.

Na kongrese EADV 2026 vo Viedni bola prezentovaná prvá kontrolovaná štúdia nechtových zmien u používateľov GLP-1 receptorových agonistov. Onycholýza bola v nej viac než štyrikrát častejšia než u porovnateľných kontrol. Pre nefrológa to nie je dermatologická kuriozita: semaglutid je dnes liek s preukázaným renoprotektívnym účinkom a predčasné vysadenie pre benígny kožný nález by znamenalo stratu doloženého prínosu pre obličky.

Práca bola prezentovaná 1. októbra 2026 v sekcii neskoro zaradených abstraktov (late-breaker) na kongrese European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) vo Viedni. Predniesla ju spoluautorka **Bianca Maria Piraccini** z Dermatologickej kliniky Univerzity v Bologni. Ide zatiaľ o kongresový abstrakt, **nie o recenzovanú publikáciu**, a tomu treba prispôsobiť váhu, ktorú jej pripisujeme.

Novosť zistenia potvrdzuje nepriamo aj systematický prehľad dermatologických účinkov GLP-1 receptorových agonistov z roku 2025, ktorý zahrnul 51 štúdií. Katalogizoval reakcie z precitlivenosti, reakcie v mieste vpichu, pruritus, urtikáriu, angioedém a bulózny pemfigoid, ako aj priaznivé účinky pri psoriáze a hidradenitis suppurativa – **nechtové zmeny medzi nimi neboli**.

Prečo signál o nechtoch patrí aj do nefrologickej ambulancie

Dôvod nie je v tom, že nefrológ lieči nechty. Je v tom, že nefrológ dnes GLP-1 receptorové agonisty **sám indikuje**.

Randomizovaná štúdia FLOW u 3 533 pacientov s diabetom 2. typu a chronickou chorobou obličiek preukázala, že semaglutid v dávke 1,0 mg týždenne znížil riziko závažných obličkových príhod o 24 % (HR 0,76; 95 % IS 0,66 – 0,88). Priaznivé boli aj všetky potvrdzujúce sekundárne ukazovatele: ročný sklon odhadovanej glomerulovej filtrácie bol miernejší o 1,16 ml/min/1,73 m², riziko závažných kardiovaskulárnych príhod kleslo o 18 % a riziko

úmrtia z akejkoľvek príčiny o 20 %. Štúdia bola predčasne ukončená na odporúčanie pri vopred plánovanej priebežnej analýze.

Z toho vyplýva praktický záver, ktorý je v tomto článku dôležitejší než samotné nechty: ak pacient s chronickou chorobou obličiek preruší liečbu pre nepríjemný, ale neškodný nechtový nález, **stratí doložený obličkový a kardiovaskulárny prínos**. Úlohou nefrológa preto nie je nechtovú zmenu prehliadnuť, ale ani z nej urobiť dôvod na vysadenie.

Druhý dôvod je populačný. GLP-1 receptorové agonisty sa pri diabete 2. typu a obezite predpisujú čoraz častejšie, teda práve v skupinách, s ktorými sa nefrológia stretáva denne.

Čo štúdia zistila

Multinacionálna štúdia porovnala **575 pacientov** užívajúcich GLP-1 receptorové agonisty s **1 329 kontrolami** s diabetom 2. typu a/alebo obezitou, ktoré tieto lieky nikdy neužívali. Účastníci boli zaradení vo Francúzsku, Spojených štátoch, Brazílii a Mexiku. Priemerné trvanie liečby bolo 18,5 mesiaca.

Nález	GLP-1 (n = 575)	Kontroly (n = 1 329)	p
Aspoň jedna nechtová zmena	66,3 %	52,8 %	< 0,001
Onycholýza	**39,3 %**	**8,7 %**	< 0,001
Dyschrómia	45,6 %	17,0 %	< 0,001
Krehkosť	58,3 %	51,1 %	< 0,005
Ryhy a zárezy	46,8 %	31,8 %	< 0,001
Nedávny úbytok hmotnosti	76,3 %	47,3 %	< 0,001

Rozdiely nie sú rovnako presvedčivé. Pri onycholýze a dyschrómii ide o niekoľkonásobok, pri krehkosti o rozdiel 7,2 percentuálneho bodu, ktorý je pri tejto veľkosti vzorky síce štatisticky významný, klinicky však nenápadný. Táto nerovnomernosť je dôležitá – naznačuje, že nejde o plošné zhoršenie stavu nechtov, ale o **špecifický profil nálezov**.

Po obmedzení analýzy iba na pacientov, ktorí schudli, sa rozdiel medzi skupinami zmenšil, ale zostal významný.

Najsilnejší argument štúdie je anatomický, nie štatistický

Najzaujímavejšia časť zistenia sa v číslach nenachádza. Formulovala ju Piraccini pri prezentácii: pri rýchlom úbytku hmotnosti sa typicky objavujú zmeny **povrchu nechtovej platničky** – ryhy, zárezy, Beauove línie, teda stopy prechodnej poruchy nechtovej matrix. Onycholýza je však niečo iné: je to **odlúčenie platničky od nechtového lôžka**, teda porucha adhézie, nie tvorby.

Práve preto autori považujú onycholýzu za nález, ktorý sa samotným chudnutím vysvetľuje ťažko, a ktorý by mohol súvisieť priamo s liekom. Je to argument z mechanizmu, nie z p-hodnoty – a je silnejší než ktorékoľvek číslo v tabuľke vyššie, pretože ponúka falzifikovateľnú hypotézu.

Tomu zodpovedá aj to, čo sa so signálom stalo po štatistickej úprave. Po zohľadnení dermatologických ochorení a nutričných deficitov sa sila niektorých asociácií zmenšila, no **onycholýza a dyschrómia zostali približne dvoj- až trojnásobne častejšie**. Pokles z viac než štvornásobku na dvoj- až trojnásobok ukazuje, že časť rozdielu skutočne vysvetľujú sprievodné faktory – a časť nie.

Sprievodná štúdia: vlasy a pokožka hlavy

Na rovnakej vzorke prebehla aj sprievodná analýza vlasových a skalpových prejavov. Jej čísla sú v tlačovej správe uvedené zaokrúhlene:

Nález	GLP-1	Kontroly
Nezvyčajné vypadávanie vlasov	50 %	34 %

Nález	GLP-1	Kontroly
Strata objemu alebo hustoty vlasov	42 %	19 %
Vypadávanie začínajúce až po začatí liečby	26 %	12 %
Začervenanie pokožky hlavy	približne trojnásobne častejšie u používateľov	

Klinicky najzaujímavejšie nie je samotné vypadávanie vlasov – to je pri rýchlom chudnutí známy jav (telogénne efluvium). Podstatné je, že vypadávanie sa u používateľov **zriedka vyskytovalo izolovane**: väčšinu prípadov sprevádzali skalpové príznaky ako svrbenie, začervenanie alebo šupinatenie.

Spoluautor Bruno Halioua k tomu uviedol, že zápal pokožky hlavy bol skôr pravidlom než výnimkou, že ho lekári bežne nehľadajú a že môže byť liečiteľný. Ak sa to potvrdí, ide o praktický odkaz: pri sťažnosti na vypadávanie vlasov sa oplatí pozrieť sa na pokožku hlavy, nielen na vlasy.

Čo signál oslabuje

Štúdia má viacero obmedzení a časť z nich je závažná.

Približne polovica používateľov udávala nechtové ťažkosti už pred začatím liečby. To je najvážnejšia výhrada a sama osebe vysvetľuje, prečo nemožno hovoriť o príčinnom vzťahu. Pri prierezovom zbere nie je možné spoľahlivo určiť, čo bolo skôr.

Údaje sú hlásené pacientmi, nie hodnotené dermatológom. Nechty neboli vyšetrené štandardizovane ani zaslepene. Pacient, ktorý o možných kožných účinkoch lieku počul, si svoje nechty všíma inak než kontrola – ide o klasické skreslenie zisťovania a hlásenia.

Označenie „case-control“ nezodpovedá dizajnu. Názov abstraktu používa termín case-control, no výber účastníkov prebiehal podľa **expozície** (užívanie GLP-1 receptorového agonistu), nie podľa **výsledku** (prítomnosť nechtovej zmeny). V pravej štúdii prípadov a kontrol je to naopak. Správnejšie je hovoriť o prierezovom porovnaní exponovaných a neexponovaných, ako to robí aj tlačová správa EADV aj odborné spravodajstvo.

Chýba aktívny komparátor. Shari Lipner, ktorá štúdiu komentovala a na nej sa nepodieľala, označila prácu za generujúcu hypotézu, nie meniacu prax, a upozornila, že nálezy môžu odrážať skreslenie zisťovania a nutričné dôsledky chudnutia, nie toxicitu lieku pre necht. Ako vhodné overenie navrhla prospektívnu kohortovú štúdiu so zaslepeným a objektívnym hodnotením nechtov, s **aktívnymi komparátormi** (inhibítory SGLT2 alebo DPP-4) a s pravidelným nutričným laboratórnym sledovaním. Práve aktívny komparátor by oddelil účinok lieku od účinku liečeného stavu a chudnutia.

Financovanie a konflikty záujmov si zasluhujú zmienku. Štúdia vznikla s inštitucionálnou podporou laboratórií DUCRAY (skupina Pierre Fabre), ktoré sa špecializujú na dermatologickú a vlasovú kozmetiku – teda spoločnosti pôsobiacej na trhu, ktorý by zo zisteného problému mohol profitovať. Piraccini uviedla grantovú alebo výskumnú podporu od spoločnosti Eli Lilly a honoráre okrem iného od Pierre Fabre/Ducray a Eli Lilly. Lipner neuviedla relevantné konflikty záujmov. Tieto skutočnosti výsledky nevyvracajú, patria však k ich posúdeniu.

Autori sami uvádzajú, že štúdia nemôže preukázať príčinný vzťah, a plánujú prospektívne sledovanie pacientov od začiatku liečby so štandardizovaným dermatologickým vyšetrením a biologickým monitorovaním.

Diferenciálna diagnostika onycholýzy

Onycholýza má široký diferenciál a pripísať ju lieku možno až po jeho zvážení. Medzi časté príčiny patria trauma a opakované mikrotraumy, nadmerný kontakt s vodou a dráždivými látkami, nechtová psoriáza, onychomykóza a ďalšie liekové príčiny vrátane fotoonycholýzy.

Osobitne treba myslieť na systémové príčiny. Onycholýza býva opisovaná pri hyperfunkcii štítnej žľazy ako takzvané Plummerove nechty; v publikovanom opise prípadu išlo o 38-ročného muža s onycholýzou pri Gravesovej chorobe. Autori odporúčajú pri nevysvetlenej onycholýze zvážiť vyšetrenie funkcie štítnej žľazy. Ide o jediný opis prípadu, teda o najslabší typ dôkazu, ktorý však upozorňuje na klinicky lacnú a dostupnú diferenciálnu úvahu.

V nefrologickej populácii sa k tomu pridávajú nutričné deficity, ktoré pri chronickej chorobe obličiek nie sú zriedkavé a ktoré rýchly úbytok hmotnosti môže prehĺbiť.

Praktický postup v nefrologickej ambulancii

Prehľadové práce o nechtových ochoreniach odporúčajú vyšetriť **všetkých 20 nechtových jednotiek**, nie iba ten necht, na ktorý sa pacient sťažuje, a podľa potreby doplniť dermatoskopiu, zobrazovacie alebo mykologické vyšetrenie. Pre nefrologickú ambulanciu z toho vyplýva nenáročný postup:

- **Opýtať sa na časový vzťah.** Boli zmeny prítomné už pred začatím liečby, alebo vznikli počas nej? Pri polovici používateľov v štúdii išlo o prvú možnosť.
- **Rozlíšiť typ zmeny.** Odlúpenie platničky od lôžka (onycholýza) má iný význam než ryhy a zárezy na povrchu, ktoré pri rýchlom chudnutí očakávame.
- **Zdokumentovať rozsah.** Jeden necht alebo viacero; ruky, nohy, alebo oboje.
- **Prejsť bežné príčiny.** Trauma, manikúra, vlhké prostredie, dráždivé látky, psoriáza, podozrenie na mykózu.
- **Zvážiť vyšetrenie štítnej žľazy** pri nevysvetlenej onycholýze.
- **Posúdiť výživu.** Pri rýchlom úbytku hmotnosti zabezpečiť dostatočný príjem bielkovín a mikroživín; u pacienta s chronickou chorobou obličiek v spolupráci s nutričným terapeutom.
- **Pri nejasnom, rýchlo progredujúcom alebo asymetrickom náleze odoslať na dermatologické vyšetrenie.** Jednostranná nechtová zmena s pigmentáciou vyžaduje vylúčenie malignity.

Pokiaľ ide o komunikáciu s pacientom, stanovisko autorov aj komentujúcej odborníčky je zhodné a strieda sa iba dôraz. Halioua uviedol, že tieto zmeny sú časté, zvyčajne benígne a nie sú dôvodom na prerušenie účinnej liečby z vlastnej iniciatívy pacienta, a že kto si všimne vypadávanie vlasov, svrbiacu či začervenanú pokožku hlavy alebo zmeny nechtov, má to spomenúť lekárovi, nie liečbu vysadiť. Lipner zasa upozornila, aby sme medzi pacientmi nevyvolávali zbytočný strach, a zároveň považuje za rozumné nechtové a vlasové zmeny pri rýchlom chudnutí vopred spomenúť spolu s odporúčaním primeraného príjmu bielkovín a mikroživín.

Pre nefrológa je z toho najdôležitejšie: **nechtový nález nie je indikáciou na vysadenie lieku s preukázaným renoprotektívnym účinkom.**

Limity

- Ide o kongresový abstrakt bez recenzovanej publikácie; číselné údaje pochádzajú z tlačovej správy EADV a z odborného spravodajstva, nie z plného textu.
- Prierezový dizajn a pacientom hlásené prejavy neumožňujú stanoviť príčinný vzťah ani časovú postupnosť.
- Približne polovica používateľov mala nechtové ťažkosti už pred liečbou.
- Chýba zaslepené objektívne hodnotenie nechtov, aktívny komparátor aj nutričné laboratórne sledovanie.
- Nie je uvedené, ktoré konkrétne GLP-1 receptorové agonisty a v akých dávkach pacienti užívali, takže nemožno posúdiť rozdiely medzi liečivami ani vzťah k dávke.
- Údaje pochádzajú zo štyroch krajín mimo strednej Európy a ich prenosnosť na slovenskú populáciu nie je overená.
- Štúdia nebola zameraná na pacientov s chronickou chorobou obličiek; prepojenie na nefrologickú prax je v tomto článku odvodené, nie prevzaté od autorov.

Článok je určený zdravotníckym pracovníkom. Nenahrádza individuálne klinické posúdenie, dermatologické vyšetrenie ani aktuálny súhrn charakteristických vlastností konkrétneho lieku. Pacient nemá liečbu GLP-1 receptorovým agonistom prerušovať bez konzultácie s ošetrujúcim lekárom.

Súvisiace články

- Renálne benefity GLP-1 liekov – dôkazový základ pre nefrologickú prax.

- Semaglutid pri CKD v reálnej praxi – porovnanie s ďalšími GLP-1 agonistami.
- Vysadenie GLP-1 liečby – prečo má predčasné prerušenie dôsledky.
- GLP-1 a ischemická optická neuropatia – iný bezpečnostný signál a ako ho čítať.
- Prehadzovanie GLP-1 agonistov pri CKD – praktický postup pri zmene liečiva.
- Semaglutid a deficit tiamínu – nutričné riziká rýchleho chudnutia.
- Farmakologická liečba obezity pri pokročilej CKD – vrátane dialyzovaných pacientov.

Zdroje

1. **Bianca Maria Piraccini, Valérie Mengeaud, Virginie Ribet, Anne Couttet, Núria Perez Cullell, Charles Taïeb, Bruno Halioua.** *Association between GLP-1 receptor agonists and nail disorders: Results from a multinational case-control study.* EADV Congress 2026, Viedeň, 30. septembra – 3. októbra 2026 (kongresový abstrakt, sekcia late-breaker).
2. **European Academy of Dermatology and Venereology.** *Nail detachment over four times more common among GLP-1 users, first controlled study finds.* Tlačová správa, 1. októbra 2026. Text tlačovej správy (PDF).
3. **Scott Harris.** *GLP-1s Linked to Nail Detachment and Other Disorders in New Study.* Medscape Medical News, 9. októbra 2026. Text správy.
4. **Bruno Halioua, Charles Taïeb, Anne Couttet, Núria Perez Cullell, Virginie Ribet, Valérie Mengeaud, Bianca Maria Piraccini.** *Association between GLP-1 receptor agonists and scalp involvement: Results from a multinational case-control study.* EADV Congress 2026, Viedeň (kongresový abstrakt).
5. **Vlado Perkovic, Katherine R. Tuttle, Peter Rossing, Kenneth W. Mahaffey, Johannes F. E. Mann, George Bakris a spol. (FLOW).** *Effects of Semaglutide on Chronic Kidney Disease in Patients with Type 2 Diabetes.* New England Journal of Medicine. 2024;391(2):109–121. DOI.
6. **Calista Persson, Allison Eaton, Harvey N. Mayrovitz.** *A Closer Look at the Dermatological Profile of GLP-1 Agonists.* Diseases. 2025;13(5):127. DOI; PMC.
7. **Debra K. Lee, Shari R. Lipner.** *Optimal diagnosis and management of common nail disorders.* Annals of Medicine. 2022;54(1):694–712. DOI; PMC.
8. **Archana Singal, Rahul Arora.** *Nail as a window of systemic diseases.* Indian Dermatology Online Journal. 2015;6(2):67–74. DOI; PMC.
9. **Malumani Malan, Zhe Dai, Wu Jianbo, Song Ji Quan.** *Onycholysis an early indicator of thyroid disease.* Pan African Medical Journal. 2019;32:31. DOI; PMC.
10. **Piaopiao Li, Jithin S. Varghese, Megha K. Shah, Rodolfo J. Galindo, Francisco J. Pasquel, Mohammed K. Ali, Hui Shao.** *Prescribing Trends of Glucagon-Like Peptide 1 Receptor Agonists for Type 2 Diabetes or Obesity.* JAMA Network Open. 2025;8(10):e2540890. DOI.

Poznámka k dôkazom: *Číselné údaje o nechtových nálezoch (575 oproti 1 329 účastníkom, 18,5 mesiaca, 66,3/52,8 %, 39,3/8,7 %, 45,6/17,0 %, 58,3/51,1 %, 46,8/31,8 %, 76,3/47,3 %) boli overené proti pôvodnému spravodajstvu Medscape z prezentácie na kongrese; zaokrúhlené údaje o vlasoch a pokožke hlavy, krajiny zaradenia, údaj o polovici používateľov s nechtovými ťažkosťami pred liečbou, zachovanie dvoj- až trojnásobku po úprave, financovanie laboratóriami DUCRAY a úplný autorský zoznam oboch abstraktov pochádzajú z overenej tlačovej správy EADV. Bibliografia prác citovaných v tomto článku bola overená cez PubMed a Crossref vrátane úplných mien autorov, ročníka, čísla, strán a DOI.* ***Opravy oproti pôvodnej predlohe:*** *v citácii práce o onycholýze pri chorobe štítnej žľazy bolo nesprávne poradie autorov (prvým autorom je Malumani Malan, nie Zhe Dai) a chybne uvedené meno tretieho autora; ide o opis jedného prípadu, nie o štúdiu. Pri práci Singalovej a Aroru chýbal rok, ročník, číslo aj strany. Predloha uvádzala, že analýzy boli upravené na vek, pohlavie a komorbidity so zachovaním významnosti – podľa tlačovej správy sa úprava týkala aj dermatologických ochorení a nutričných deficitov a silu asociácií znížila z viac než štvornásobku na dvoj- až trojnásobok. Predloha neuvádzala, že približne polovica používateľov mala nechtové ťažkosti už pred liečbou, ani zdroj financovania štúdie a konflikty záujmov.* ***Vlastným odborným spracovaním*** *je prepojenie na štúdiu FLOW a na nefrologickú indikáciu GLP-1 receptorových agonistov, výhrada k označeniu dizajnu ako „case-control“, zdôraznenie*

anatomického rozdielu medzi poruchou adhézie a poruchou tvorby nechtovej platničky, poznámka o chýbajúcom aktívnom komparátore a celý praktický postup pre ambulanciu.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=glp1-agonisty-onycholyza-nechty-eadv-2026 · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.